



**RSI SULTAN
AGUNG**
ISLAMIC TEACHING HOSPITAL

Halaman Judul

PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT DALAM TAHUN 2024



PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 8538 /PER/RSI-SA/V/2024
TENTANG
PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT DALAM
DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang** : a. bahwa penyusunan standar pelayanan kedokteran bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien serta mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan klinis Penyakit Dalam perlu penyempurnaan Panduan Praktik Klinis Penyakit Dalam sebagai acuan pelayanan dokter spesialis Penyakit Dalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentang Panduan Praktik Klinis Penyakit Dalam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/IX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 14/SK/YBW-SA/I/2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Masa Bakti 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT DALAM**

Pasal 1

Panduan Praktik Klinis adalah panduan prosedur standar dalam pelayanan dan perawatan kepada pasien yang harus diketahui dan dijalankan oleh seorang dokter untuk melaksanakan kegiatan kesehatan secara optimal, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan acuan bagi dokter dalam memberikan pelayanan di Rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Pasal 3

Panduan Praktik Klinis Dokter di Rumah Sakit meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit, diambil berdasarkan kriteria:

1. Penyakit yang prevalensinya cukup tinggi;
2. Penyakit yang membutuhkan biaya tinggi; dan
3. Penyakit yang risiko tinggi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Utama ini berlaku, Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 527/PER/RSI-SA/I/2020 tentang Panduan Praktik Klinik Penyakit Dalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 5 Dzulqo'dah 1445 H

5 Mei 2024 M

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

 **RSI SULTAN AGUNG**

ISLAMIC TEACHING HOSPITAL

 Prof. Dr. d. AGUNG PUTRA, M.Si.Med

SEMARANG - JAWA TENGAH

PENYUSUN
PANDUAN PRAKTIK KLINIS
PENYAKIT DALAM

NO	NAMA	SPESIALISASI
1.	dr. M. Saugi Abduh, Sp.PD, KKV, FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
2.	dr. Erwin Budi Cahyono, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
3.	dr. Lusito, Sp.PD., KGH	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
4.	dr. Nur Anna Chalimah Sa'dyah, Sp.PD, KEMD, FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
5.	dr. Tri Ferry Rachmatullah, Sp. PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
6.	dr. Rino Arianto Marswita, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
7.	DR. dr. Shofa Chasani, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
8.	dr. Suyono, Sp.PD, K-HOM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
9.	dr. M. Arif, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
10.	dr. Retno Widyastuti, M.Si.Med, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam



DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT DALAM.....	2
PENYUSUN	4
DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR	6
PENDAHULUAN.....	7
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DIABETES MELITUS TIPE 2	11
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DEMAM BERDARAH DENGUE	16
PANDUAN PRAKTIK KLINIS HEPATITIS VIRUS AKUT.....	21
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DEMAM TYPHOID.....	23
PANDUAN PRAKTIK KLINIS GAGAL JANTUNG.....	25
PANDUAN PRAKTIK KLINIS HIPERTENSI	28
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DIARE AKUT.....	31
PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT GINJAL KRONIK	34
PANDUAN PRAKTIK KLINIS ASMA	37
PANDUAN PRAKTIK KLINIS TUBERKULOSIS	41
PANDUAN PRAKTIK KLINIS ANEMIA.....	46
PANDUAN PRAKTIK KLINIS PERDARAHAN SALURAN CERNA BAGIAN BAWAH (Hematochezia)	48
PANDUAN PRAKTIK KLINIS PERDARAHAN SALURAN CERNA BAGIAN ATAS.....	50
PANDUAN PRAKTIK KLINIS SIROSIS HEPATIS	53
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DIARE KRONIS.....	56
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DISPEPSIA FUNGSIONAL.....	58
PENUTUP	60



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Demi kelancaran Pelayanan Medis Dokter Spesialis Penyakit Dalam, maka perlu dibuat Prosedur Tetap dalam bentuk Panduan Praktik Klinis sebagai acuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam bertugas. Adanya buku ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi tenaga medis dan pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan, selain itu juga dapat menjadi bahan referensi.

Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Staf Medis atas kerjasamanya yang baik dalam menyusun buku prosedur tetap penyakit dalam ini.

Kami berharap agar keberhasilan yang telah dicapai akan memacu kita semua untuk turut menambah buku-buku ilmiah yang berguna bagi peningkatan pelayanan penyakit dalam.

Semoga keberadaan buku Panduan Praktik Klinis ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 5 Mei 2024

Penyusun



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 2538/PER/RSI-SA/V/2024
TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT
DALAM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan perorangan; lingkup pelayanan adalah segala tindakan atau perilaku yang diberikan kepada pasien dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Substansi pelayanan medis adalah praktik ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang telah ditapis secara sosio – ekonomi –budaya yang mengacu pada aspek pemerataan, mutu dan efisiensi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat akan pelayanan medis.

Untuk menyelenggarakan pelayanan medis yang baik dalam arti efektif, efisien dan berkualitas serta merata dibutuhkan masukan berupa sumber daya manusia, fasilitas, prafasilitas, peralatan, dana sesuai dengan prosedur serta metode yang memadai

Saat ini sektor kesehatan melengkapi peraturan perundang-undangnya dengan disahkannya Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada bulan Oktober 2004 yang diberlakukan mulai bulan Oktober 2005. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter/dokter Penyakit dalam, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter/dokter Penyakit dalam.

Panduan praktik klinis (*Clinical practice guidelines*) merupakan panduan yang berupa rekomendasi untuk membantu dokter atau dokter Penyakit dalam dalam memberikan pelayanan kesehatan. Panduan ini berbasis bukti (berdasarkan penelitian saat ini) dan tidak menyediakan langkah-pendekatan untuk perawatan dan pengobatan, namun memberikan informasi tentang pelayanan yang paling efektif. Dokter atau dokter Penyakit dalam menggunakan panduan ini sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk menentukan rencana pelayanan yang tepat kepada pasien

B. Tujuan

1. Meningkatkan mutu pelayanan pada keadaan klinis dan lingkungan tertentu
2. Mengurangi jumlah intervensi yang tidak perlu atau berbahaya
3. Memberikan opsi pengobatan terbaik dengan keuntungan maksimal
4. Memberikan opsi pengobatan dengan risiko terkecil
5. Memberikan tata laksana dengan biaya yang memadai



PANDUAN PRAKTIK KLINIS SIROSIS HEPATIS		
1	Definisi (Pengertian)	Penyakit kronis hati yang ditandai dengan fibrosis, disorganisasi dari lobus dan arsitektur vaskular, dan regenerasi nodul hepatosit
2	Anamnesis	Stadium awal sirosis sering tanpa gejala sehingga kadang ditemukan pada waktu pasien melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau karena kelainan penyakit lain. Bila sirosis hati sudah lanjut, gejala-gejala lebih menonjol : 1. dispepsia 2. malaise dan fatigue 3. hilangnya rambut badan 4. gangguan tidur 5. subfebris 6. gangguan pembekuan darah, perdarahan gusi, epistaksis, gangguan siklus haid, 7. air kemih berwarna seperti teh pekat, 8. muntah darah dan/atau melena, 9. perubahan mental, meliputi mudah lupa, sukar konsentrasi, bingung, agitasi, sampai koma Perlu dilakukan anamnesis lanjutan untuk mengetahui faktor risiko sirosis hepatitis: 1. riwayat sakit kuning (sakit hepatitis) 2. riwayat penggunaan obat hepatotoksik 3. riwayat alkohol 4. riwayat kenaikan profil lemak darah
3	Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi: 1. Status nutrisi dan kesadaran a. Kepala dan leher 1) Sklera ikterik 2) Conjunktiva pucat b. Toraks 1) Spider nevi 2) Ginekomastia c. Abdomen 1) Caput medusa 2) Ascites 3) Splenomegali 4) Atrofi testis d. Extremitas 1) Flapping tremor



		2) Eritema plamaris 3) Edema extremitas																											
4	kriteria Diagnosis	Ditemukan stigmata hepar kronis yang ditunjang dengan gangguan tes fungsi hati dan gangguan struktur hati melalui pencitraan radiologi. <table><tr><th rowspan="2">Parameter</th><th colspan="3">Skor</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>Ascites</td><td>-</td><td>ringan</td><td>Sedang-berat</td></tr><tr><td>Ensefalopati</td><td>-</td><td>ringan</td><td>Sedang-berat</td></tr><tr><td>Albumin</td><td>>3.5</td><td>2.8-3.5</td><td><2.8</td></tr><tr><td>Bilirubin</td><td><2</td><td>2-3</td><td>> 3</td></tr><tr><td>Prothrombin</td><td>1-3</td><td>4-6</td><td>>6</td></tr></table> Child-Turcotte-Pugh A : 5-6 (prognosis baik) Child-Turcotte-Pugh B : 7-9 (prognosis sedang) Child-Turcotte-Pugh C : 10-15 (prognosis buruk)	Parameter	Skor			1	2	3	Ascites	-	ringan	Sedang-berat	Ensefalopati	-	ringan	Sedang-berat	Albumin	>3.5	2.8-3.5	<2.8	Bilirubin	<2	2-3	> 3	Prothrombin	1-3	4-6	>6
Parameter	Skor																												
	1	2	3																										
Ascites	-	ringan	Sedang-berat																										
Ensefalopati	-	ringan	Sedang-berat																										
Albumin	>3.5	2.8-3.5	<2.8																										
Bilirubin	<2	2-3	> 3																										
Prothrombin	1-3	4-6	>6																										
5	Diagnosa Kerja	Sirosis hepatitis																											
6	Diagnosa Banding	1. Hepatitis kronik aktif 2. Hepatocellular carcinoma																											
7	Pemeriksaan penunjang	1. Pemeriksaan darah Bertujuan untuk uji fungsi hati (seperti SGOT, SGPT, bilirubin direk dan indirek, protein total, albumin, globulin, Gamma GT, alkali fosfatase). Pemeriksaan serologi virus hepatitis (hepatitis B dan atau C) sebagai penyebab sirosis. Fungsi pembekuan darah (PPT, aPTT, INR). Pemeriksaan penanda kanker hati dilakukan bila ada indikasi (alfa fetoprotein) 2. Uji pencitraan Pemeriksaan secara visual, seperti USG abdomen, CT scan. 3. Biopsi organ hati Pemeriksaan sampel jaringan hati dilakukan jika metode lain belum jelas untuk memastikan sirosis. 4. Pemeriksaan gastroskopi Melihat pelebaran pembuluh darah di kerongkongan (varises esofagus) yang berisiko pecah dan penyebab lainnya (gastropati hipertensi porta).																											
8	Terapi	1. Pemberian obat menyesuaikan dengan tanda dan gejala yang didapatkan. a. Ascites : diberikan furosemide 40 - 160 mg/hari dan atau spironolacton dosis 100 – 400 mg/hari. Bila pasien sirosis dengan ascites dan ditemukan hiponatremia, diberikan obat competitive vasopressin receptor 2 antagonist (Tolvaptan 1 x 15 mg hingga 1 x 30 mg) b. Hipertensi porta: dapat diberikan propranolol dengan dosis 2x10mg hingga 3x20mg/ hari dengan target denyut nadi 60x/menit atau yang dapat ditoleransi oleh pasien. Terapi propranolol dapat dikombinasikan dengan isosorbid mononitrat. c. Pemanjangan diastase perdarahan: dapat diberikan vit K 3x1 tab sesuai dengan INR.																											



		d. Laktulosa dengan target BAB 1-2x sehari e. Bila ada perdarahan akut saluran cerna bagian atas tipe variceal maka harus diberikan obat-obat parenteral yang efektif menurunkan tekanan porta, seperti : Terlipressin, Somatostatin, Octreotide. 2. Terapi penyakit dasar diberikan sesuai etiologi: misal pemberian anti virus pada pasien sirosis
9	Edukasi	1. Edukasi gizi dan pola makan Diet seimbang (sesuai kondisi klinis) Jika didapatkan ascites diberikan diet rendah garam serta pengaturan asupan cairan 2. Edukasi faktor risiko Mendapatkan terapi terkait etiologi sirosis 3. Edukasi gaya hidup sehat Istirahat cukup 4. Edukasi obat-obatan Meminum obat secara teratur. Menyampaikan ke dokter apabila ada efek samping pemberian obat (bradikardia/hipotensi)
10	Prognosis	Prognosis tergantung dari stadium skor Child-Pugh (A, B atau C) Ad vitam : ad malam Ad sanationam : ad malam Ad fungsionam : ad malam
12	Pustaka	Panduan Praktik Klinis Penatalaksanaan Di Bidang Ilmu Penyakit Dalam, Interna publishing, 2015 Nurdjanah S, Sirosis Hepatis, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi VI Jilid II Bab 255. 2014



PANDUAN PRAKTIK KLINIS DIABETES MELITUS TIPE 2		
1	Definisi	Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya
2	Anamnesis	1. Keluhan klasik DM : poliuria, polidipsi, polifagia dan penurunan BB yang tidak dapat dijelaskan sebabnya 2. Keluhan lain dapat berupa : lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulvae pada wanita
3	Pemeriksaan fisik	1. Tinggi badan, berat badan, hitung indeks massa tubuh 2. Tekanan darah (dapat ditambahkan pemeriksaan tekanan darah pada kondisi berdiri) 3. Pemeriksaan jantung 4. Pulsasi pada beberapa arteri : dorsalis pedis, poplitea, tibialis posterior 5. Pemeriksaan kaki khususnya bila ditemukan komplikasi neuropati atau ulkus
4	Pemeriksaan penunjang	Pemeriksaan laboratorium 1. Glukosa plasma puasa (tidak ada asupan kalori minimal 8 jam), atau 2. Glukosa plasma 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, atau 3. Glukosa plasma sewaktu, atau 4. Hb A1c Pemeriksaan penunjang lain : 1. EKG 2. Radiologi seperti x-foto pedis; x-foto thorax, USG-doppler 3. Funduskopi
5	Kriteria Diagnosis	1. Gejala klasik DM+glukosa plasma sewaktu $\geq 200\text{mg/dl}$ Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir, atau 2. Kadar glukosa plasma puasa $\geq 126\text{mg/dl}$ Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam, atau 3. Kadar gula plasma 2 jam pada TTGO $\geq 200\text{mg/dl}$ TTGO yang dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gr glukosa yang dilarutkan ke dalam air, atau 4. Pemeriksaan HbA1c $>6,5\%$ dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh NGSP
6	Diagnosa Kerja	Diabetes Melitus tipe 2
7	Diagnosa Banding	1. Toleransi Glukosa Terganggu 2. Glukosa Darah Puasa Terganggu



8	Terapi	1. Edukasi Edukasi meliputi pemahaman tentang : a. penyakit DM b. makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara berkelanjutan c. penyulit DM dan risikonya d. intervensi farmakologis dan nonfarmakologis e. interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat hipoglikemik oral atau insulin serta obat-obatan lain f. Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah g. Mengatasi sementara keadaan gawat darurat h. Pentingnya latihan jasmani yang teratur i. Masalah khusus yang dihadapi j. Pentingnya perawatan kaki k. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan 2. Terapi Nutrisi Medis a. Perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal, jenis dan jumlah makanan b. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi : karbohidrat 45-65%, lemak 20-25%, protein 10-15% c. Penghitungan kebutuhan kalori : Perhitungan BB idaman (BBI) dengan rumus Brocca: $BBI = (TB \text{ dalam cm} - 100) \times 90\% \times 1\text{kg}$ Bagi pria dengan TB <160cm dan wanita TB< 150cm, rumus dimodifikasi menjadi : $BBI = (TB \text{ dalam cm} - 100) \times 1\text{kg}$ BB Normal : $BB \text{ ideal} \pm 10\%$ Kurus : $BB \text{ ideal} - 10\%$ Gemuk : $BB \text{ ideal} + 10\%$ Jumlah kalori basal per hari : Laki-laki : 30 kal/kgBB idaman Wanita : 25kal/kgBB idaman Penyesuaian (terhadap kalori basal/hari) : Umur 40-49 tahun : -5% 60-69 tahun : -10% >70tahun : -20% 1) Aktivitas fisik Istirahat +10% Aktivitas ringan +20% Aktivitas sedang +30% Aktivitas sangatBerat +50%
---	--------	---



		2) Status gizi (Berat Badan) BB gemuk -20% BB lebih -10% BB kurus +20-30% Makanan sejumlah kalori terhitung dengan komposisi diatas dibagi dalam 3 porsi besar untuk makan pagi(20%), siang (30%), dan sore (25%), serta 2-3porsi makanan ringan 3. Latihan jasmani Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur (3-4kali seminggu selama kurang lebih 30 menit) dengan prinsip CRIPE (Continuous, Rhythmical, Interval, Progressive, Endurance) 4. Terapi obat anti diabetik (dosis disesuaikan dengan evaluasi kadar gula) a. Insulin secretagogue : Glimepiride 1 mg, 2mg, 3mg , 4mg 1x sehari Glicuidone 30mg diberikan 1-3x sehari Gliclazide 80mg diberikan 1-2x sehari (untuk sediaan MR 30 dan 60 mg diberikan 1-2x sehari) Glibenclamide 2.5mg, 5 mg 1 x sehari b. Insulin sensitizing biguanid : Metformin 500 mg diberikan 1-3x sehari (dosis optimal 1500 – 2000 mg sehari) c. Thiazolidinedione Pioglitazone 15mg. 30mg diberikan 1x sehari d. Penghambat alfa glukosidase : Acarbose 50mg , 100mg diberikan 1-3xsehari e. DPP-IV inhibitor: Vildagliptin 50 mg diberikan 2x sehari Sitagliptin 100 mg diberikan 1x sehari Saxagliptin 5 mg 1x sehari Linagliptin 5 mg 1x sehari f. SGLT-2 inhibitor : Dapaglifozin 1 x 5 mg, atau Empaglifozin 1 x 10 mg g. Kombinasi (kombinasi dosis tetap), contoh sulfonilurea dan metformin, thiazolidinedione dan metformin, DPP-IV inhibitor dan metformin Insulin diberikan sesuai dengan indikasi : 1. HbA1C saat diperiksa > 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes 2. HbA1C saat diperiksa > 9% 3. Penurunan BB yang cepat
--	--	--

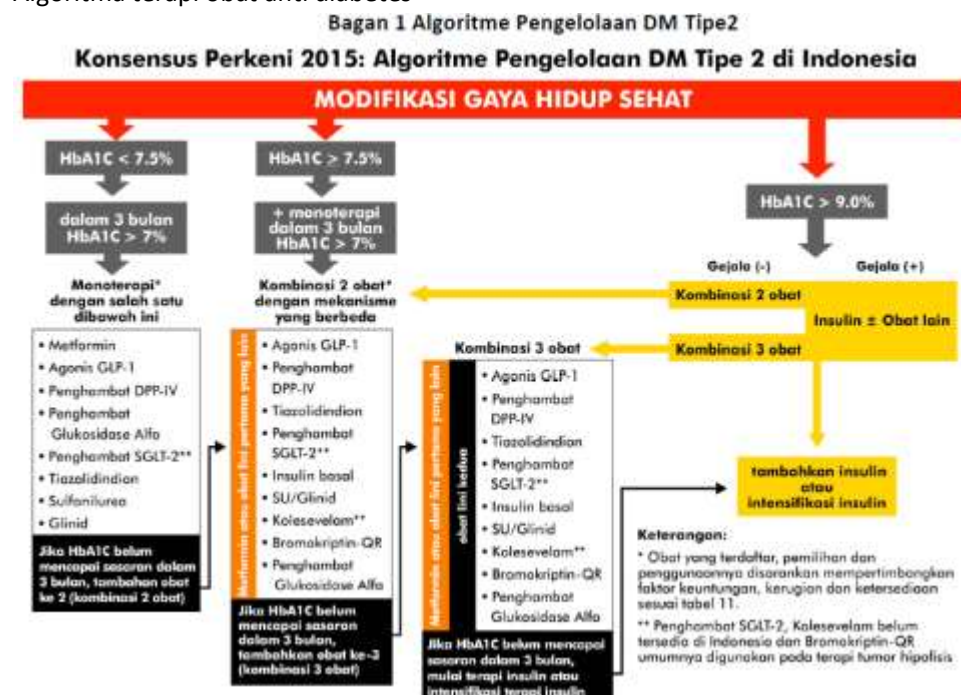


4. Krisis hiperglikemia : ketoasidosis, hiperglikemik hiperosmolar state
5. Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal
6. Stres berat(infeksi sistemik, operasi besar, IMA, stroke)
7. Kehamilan dengan DM/DM gestasional yang tidak terkontrol dengan perencanaan makan
8. Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat
9. Kontraindikasi atau alergi terhadap OHO
10. Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi

Jenis insulin (disesuaikan dengan kondisi pasien):

1. Human insulin short acting (Actrapid HM Penfill dan Humulin R)
2. Human insulin intermediate acting (Insulatard HM intermediate acting)
3. Human insulin mix acting (Mixtrad 30 HM combine with short acting)
4. Analog insulin rapid acting (Insulin aspart, Insulin lispro, Insulin Glulisin)
5. Analog insulin intermediate (insulatard HM penfill)
6. Analog insulin intermediate combine with short acting (Novomix flexpen 30/70 dan Humalog mix 25/75 dan humalog mix 50/50)
7. Analog insulin long acting (Insulin detemir, Insulin glargine)

Algoritma terapi obat anti diabetes



9	Edukasi	Sesuai terapi edukasi
10	Prognosis	Dubia ad bonam
11	Kompetensi	LOC 4Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Pemberian terapi

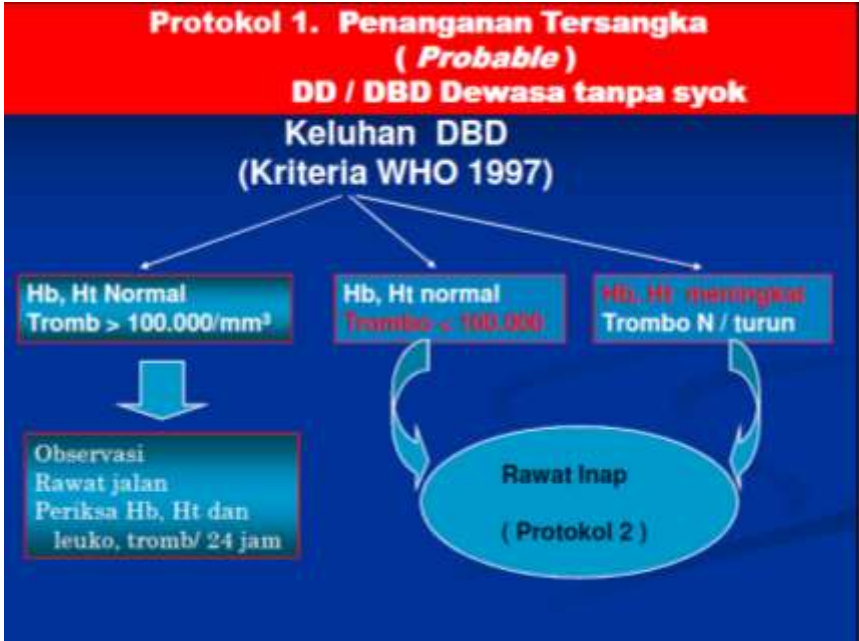
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap: 1. Gula darah terkendali 2. Pasien sudah mendapatkan edukasi tentang diet, latihan jasamni dan efek samping obat diabetes
14	Kepustakaan	1. Konsensus Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Indonesia 2019



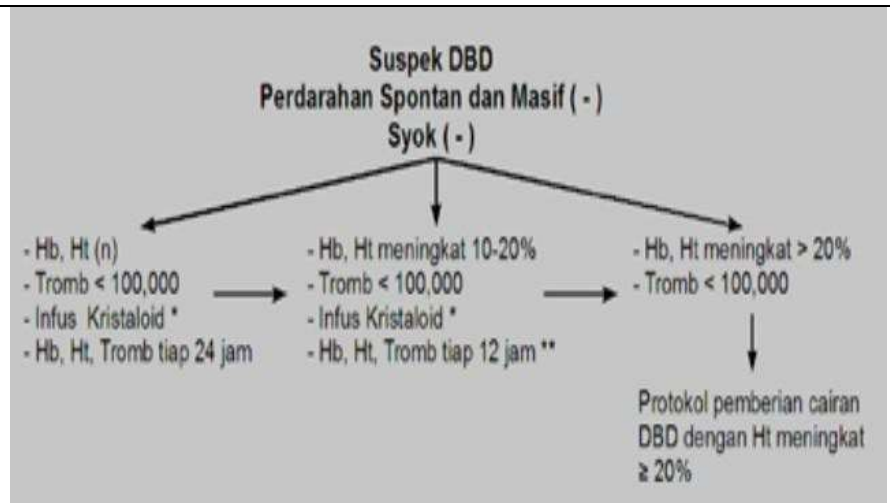
PANDUAN PRAKTIK KLINIS DEMAM BERDARAH DENGUE

1	Definisi (Pengertian)	Demam berdarah dengue adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus serta memenuhi kriteria WHO untuk demam berdarah dengue (DBD)
2	Anamnesis	1. Demam atau riwayat demam akut, antara 2-7 hari, biasanya bifasik 2. Sakit kepala 3. Nyeri retro orbital 4. Mialgia 5. Artralgia Ditemukan pada musim penghujan dengan didapatkan riwayat DBD di sekitar tempat tinggal pasien
3	Pemeriksaan fisik	1. Febris 2. Uji tourniquet positif (>20 petekie dalam 2,54cm²) 3. Petekie, ekimosis, atau purpura 4. Hepatomegali 5. Perdarahan mukosa, saluran cerna, bekas suntikan, atau tempat lain 6. Tanda kebocoran plasma (efusi pleura)
4	Pemeriksaan penunjang	1. Darah rutin : trombositopenia, leukopenia, kenaikan hematokrit 2. Serologi dengue : IgM anti dengue (+) NS-1 (+) 3. Foto thorax: ditemukan efusi pleura
5	kriteria Diagnosis	Kriteria diagnosis WHO 2011 untuk DBD : Kriteria klinis: 1. Demam atau riwayat demam akut, antara 2-7 hari, biasanya bifasik 2. Terdapat minimal satu dari manifestasi perdarahan berikut ini : a. Uji tourniquet positif (>20 petekie dalam 2,54cm²) b. Petekie, ekimosis, atau purpura c. Perdarahan mukosa, saluran cerna, bekas suntikan, atau tempat lain d. Hematemesis atau melena 3. Pembesaran hati 4. Syok dengan tanda takikardia atau gangguan perfusi jaringan Kriteria laboratorium: 5. Trombositopenia ($\leq 100.000/mm^3$) 6. Terdapat minimal satu tanda-tanda plasma leakage a. Hematokrit meningkat $\geq 20\%$ dibanding hematokrit rata-rata pada usia, jenis kelamin dan populasi yang sama b. Hematokrit turun hingga $\geq 20\%$ dari hematokrit awal, setelah pemberian cairan c. Terdapat efusi pleura, efusi perikard, ascites dan



		hipoproteinemia 2 kriteria klinis pertama disertai tanda laboratorium cukup untuk menegakkan diagnosa klinis DBD. Derajat DBD: 1. Derajat I : Demam disertai gejala konstitusi yang tidak khas, manifestasi perdarahan hanya berupa uji torniquet positif dan atau mudah memar 2. Derajat II : Derajat I disertai perdarahan spontan 3. Derajat III : Terdapat kegagalan sirkulasi : nadi cepat dan lemah atau hipotensi, disertai kulit dingin dan lembab serta gelisah 4. Derajat IV : Renjatan :tekanan darah dan nadi tidak teratur. DBD derajat III dan IV digolongkan dalam sindrom renjatan dengue
6	Diagnosa Kerja	Demam Berdarah Dengue
7	Diagnosa Banding	1. Chikungunya 2. Leptospirosis 3. Demam typhoid 4. Influenza
8	Terapi	Terapi cairan berdasarkan protokol tatalaksana DBD: Protokol 1 penanganan tersangka DD/DBD dewasa tanpa syok  Protocol 2. Pemberian cairan pada tersangka DBD dewasa

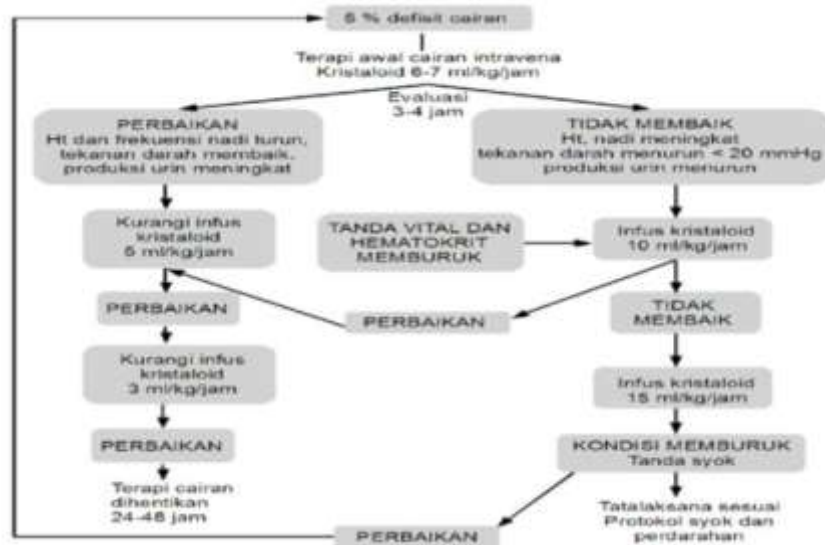




Rumus volume cairan kristaloid per hari yang diperlukan :

$$1500 + ((20 \times (\text{BB dalam kg} - 20))$$

Protocol 3. Penatalaksanaan DBD dengan peningkatan HT > 20%



Protocol 4. Penatalaksanaan perdarahan spontan pada DBD

		Protokol 4. Penatalaksanaan Perdarahan Spontan pada DBD dewasa KASUS DBD : Perdarahan Spontan dan Masif : - Epistaksis tidak terkendali - Hematemesis melena - Perdarahan otak Syok (-) ↓ Hb, Ht, Trombo, Leuko, Pemeriksaan Hemostasis (KID) Golongan darah, uji cocok serasi KID + HEPARINISASI 5000 – 10.000 / 24j ↓ Transfusi komponen darah : * PRC (Hb<10 g %) * FFP (APTT > 1,5 X normal) * TC (Tromb.<100.000) * Pemantauan Hb, Ht, Tromb. Tiap 4-6 jam * Ulang pemeriksaan hemostasis 24 jam kemudian
		Protokol 5. Tata laksana syok pasien dewasa
9	Edukasi	1. Edukasi tentang prognosis jika terjadi DSS 2. Edukasi gaya hidup sehat kebersihan lingkungan (setelah sehat)
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap 1. Tampak perbaikan klinis 2. Tidak demam selama 24 jam tanpa anti piretik



		3. Tidak ada distres pernapasan 4. Hematokrit stabil 5. Jumlah trombosit cenderung naik ; > 50.000/ml 6. Tiga hari setelah syok teratasi 7. Nafsu makan baik
14	Kepustakaan	WHO 2011. Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever



PANDUAN PRAKTIK KLINIS HEPATITIS VIRUS AKUT		
1	Definisi	Hepatitis virus akut adalah inflamasi hati akibat infeksi virus hepatitis yang berlangsung < 6 bulan. Paling sering disebabkan oleh virus hepatotropic (A,B,C,D)
2	Anamnesis	Gejala sistemik: 1. Demam 2. Malaise 3. fatigue 4. Kuning (icteric) 5. Nyeri otot 6. Urine berwarna gelap Gejala saluran cerna: 1. Mual 2. Muntah 3. Nyeri perut kuadran kanan atas Pasien memiliki faktor resiko terkait virus hepatitis: kontaminasi fekal oral/ kontaminasi darah
3	Pemeriksaan fisik	1. Demam 2. Sclera ikterik 3. Kulit berwarna kuning 4. Hepatomegali
4	Pemeriksaan penunjang	Darah rutin Liver Function Test: 1. Bilirubin total 2. Bilirubin direct 3. Bilirubin indirect 4. ALT 5. AST 6. Alkali fosfatase Seromarker hepatitis: 1. IgM HAV 2. HBsAg 3. Anti HBs 4. Ig M anti HBc 5. HBeAg 6. HBV DNA 7. Anti HCV & HCV RNA
5	Kriteria Diagnosis	1. Terdapat tanda dan gejala hepatitis akut 2. Terdapat kenaikan titer ALT, AST, bilirubin 3. Sero marker hepatitis virus (+)



6	Diagnosa Kerja	Hepatitis virus akut
7	Diagnosa Banding	1. Hepatitis karena obat 2. Hepatitis alkoholik 3. NAFLD
8	Terapi	Terapi suportif: 1. Tirah baring 2. Diet agar hidrasi dan kalori cukup, pembatasan protein hanya pada pasien ensefalopati hepatic 3. Terapi simptomatis Mual dapat diberikan metoclopramide 10mg injeksi jika perlu. Diberikan H2 blocker injeksi ranitidin 50mg/12jam. Demam diberikan antipiretik. Pada keadaan hepatitis B akut fulminant dapat diberikan obat anti virus misal: 1. Lamivudin 1x100 atau 2. Telbivudin 600mg atau 3. Tenofovir 300mg atau 4. Entecavir 0,5 mg
9	Edukasi	Edukasi tentang resiko penularan Edukasi untuk dilakukan vaksinasi Edukasi untuk kemungkinan menjadi hepatitis kronik pada hepatitis B dan C
10	Prognosis	Jika tidak ditemukan hepatitis fulminant : Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap: 1. Pasien tidak ada tanda hepatitis fulminant 2. Tidak ada tanda encephalopathy hepaticum 3. Tidak ditemukan tanda dan gejala hepatitis akut
14	Kepustakaan	Nurdjanah S, Hepatitis Akut, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi VI Jilid II Bab 252. 2014



PANDUAN PRAKTIK KLINIS DEMAM TYPHOID		
1	Definisi	Demam tifoid merupakan penyakit sistemik akut yang disebabkan oleh infeksi kuman <i>Salmonella typhi</i> atau <i>Salmonella paratyphi</i>
2	Anamnesis	1. Demam naik secara bertahap pada minggu pertama, lalu demam menetap(kontinyu)atau remitten pada minggu kedua 2. Demam terutama sore/malam hari 3. Sakit kepala 4. Nyeri otot 5. Anoreksia 6. Mual, muntah 7. Konstipasi atau diare
3	Pemeriksaan fisik	1. Febris 2. Kesadaran berkabut/apatis 3. Bradikardia relatif (peningkatan suhu 1°C tidak diikuti peningkatan denyut nadi 8x/menit) 4. Lidah berselaput(kotor di tengah, tepi dan ujung merah, serta tremor) 5. Hepatomegali 6. Splenomegali 7. Nyeri abdomen 8. Roseola (jarang pada orang Indonesia)
4	Pemeriksaan penunjang	1. Darah perifer lengkap 2. Serologi Widal atau Tubex atau IgM <i>Salmonella</i> 3. Tes fungsi hati (dilakukan jika ada indikasi) 4. Kultur (dilakukan jika ada indikasi misal sepsis)
5	Kriteria Diagnosis	1. Sesuai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 2. Laboratorium: a. Darah rutin : Dapat ditemukan lekopeni, leukositosis atau normal, Anesonifilia, Limfopenia, Peningkatan LED, Anemia ringan, Trombositopenia, b. Test Tubex>6 atau IgM <i>Salmonella</i>(+) c. Widal: Peningkatan titer uji widal ≥ 4kali lipat setelah satu minggu memastikan diagnose, Uji widal tunggal dengan titer antibodi O 1/320 atau H 1/640 disertai gambaran klinis khas menyokong diagnosis d. Kultur darah (+) (jika ada indikasi) e. Test fungsi liver : dapat muncul Gangguan fungsi hati
6	Diagnosa Kerja	Demam Typhoid
7	Diagnosa Banding	1. Infeksi virus 2. Leptospirosis



		3. Malaria
8	Terapi	- Nonfarmakologis: tirah baring, makanan lunak rendah serat - Farmakologis Simptomatis Antibiotik : - Sefalosporin generasi III : seftriakson 2 gram dalam dekstrosa 100cc selama ½ jam per infus sekali sehari selama 5 hari. Atau alternatif dapat diberikan sefotaksim 2-3x1gram, sefoperazon 2x1gram - Flourokuinolon - Siprofloksasin 2x500mg/hari p.o selama 6 hari atau 400mg/12jam IV - Ofloksasin 2x400mg/hari selama 7hari - Levofloksasin 1x 500/hari selama 7 hari po/IV
9	Edukasi	Edukasi menjaga kebersihan makanan Edukasi meminum obat hingga habis sesuai petunjuk dokter
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungtionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap - Pasien 48 jam tidak demam tanpa anti piretik - Hemodinamik stabil - Pasien dapat makan dan minum
14	Kepustakaan	- Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam edisi VI bab Demam Typhoid tahun 2014 - Panduan praktik klinik perhimpunan dokter penyakit dalam indonesia



PANDUAN PRAKTIK KLINIS GAGAL JANTUNG		
1	Definisi	Gagal jantung adalah kumpulan gejala yang kompleks dimana seorang pasien harus memiliki tampilan berupa: Gejala gagal jantung (nafas pendek yang tipikal saat istirahat atau saat melakukan aktivitas disertai / tidak kelelahan); tanda retensi cairan (kongesti paru atau edema pergelangankaki); adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi jantung saat istirahat
2	Anamnesis	Pasien mengeluh kan gejala : 1. Sesak nafas 2. <i>Ortopneu</i> 3. <i>Paroxysmal nocturnal dyspnoe</i> 4. Toleransi aktifitas yang berkurang 5. Cepat lelah 6. Begkak di pergelangankaki 7. Batuk di malam / dini hari 8. Mengi 9. Berat badan bertambah >2 kg/minggu 10. Berat badan turun (gagal jantung stadium lanjut) 11. Perasaan kembung/ begah 12. Nafsu makan menurun 13. Perasaan bingung (terutama pasien usia lanjut) 14. Depresi 15. Berdebar 16. Pingsan Terdapat riwayat faktor risiko gagal jantung (misal: hipertensi, DM, merokok)
3	Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan fisik 1. Keadaan umum: kesadaran, status nutrisi, berat badan 2. Nadi: frekuensi, ritme, konfigurasi nadi 3. Tekanan darah: sistolik, diastolik, tekanan nadi 4. Tanda kelebihan cairan: tekanan vena jugularis, edem perifer, hepatomegali, ascites 5. Paru Paru: frekuensi napas, ronki basah, efusi pleura 6. Jantung: perpindahan Apex jantung, irama Gallop, suara jantung ke 3, bising jantung Didapatkan tanda tanda: 1. Peningkatan JVP 2. Refluks hepatojugular 3. Suara jantung S3 (gallop) 4. Apex jantung bergeser ke



		5. Lateral 6. Bising jantung 7. Edema perifer 8. Kreпитasi pulmonal 9. Suara pekak di basal parupada perkusi 10. Takikardia 11. Nadi ireguler 12. Nafas cepat 13. Hepatomegali 14. Asites 15. Kaheksia
4	Pemeriksaan penunjang	1. EKG: normal, iskemia, infark miokard, aritmia, 2. Foto thorax: cardiomegali, edema paru 3. Echocardiography: hipokinetik, ejeksi fraksi yang menurun 4. Pemeriksaan laboratoirium: a. Darah Rutin b. Gula Darah c. Profil Lipid d. Ureum-Kreainin dan e GFR e. Natiuretic peptide f. Elektrolite Darah (sesuai jika ada indikasi) g. Urinalisis (sesuai jika ada indikasi) h. Test Fungsi Hati(sesuai jika ada indikasi) i. Tes fungsi Tiroid (sesuai jika ada indikasi)
5	kriteria Diagnosis	Ditemukan tanda dan gejala yang sesuai dengan gagal jantung disertai pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan kelainan jantung
6	Diagnosa Kerja	Gagal jantung
7	Diagnosa Banding	1. Penyakit paru: pneumonia, asma, emboli paru 2. Penyakit ginjal: gagal ginjal kronik 3. Penyakit anemia
8	Terapi	Terapi non farmakologi: 1. Tirah baring untuk NYHA grade III-IV 2. Diet rendah garam 3. Batasi intake cairan 4. Hentikan rokok, alcohol 5. Batasi/sesuaikan aktivitas fisik Terapi farmakologi (dosis sesuai dengan kondisi pasien) : 1. Diuretic diberikan untuk menghilangkan tanda dan gejala congestif Furosemide 40mg 2. ACEI (atau ARB jika ACEI tidak dapat ditoleransi) Captopril 12,5mg, 25mg, 50mh, 3x sehari Lisinopril 5mg, 10mg 1x sehari



		Ramipril 2.5mg, 5mg, 10mg 1x sehari Candesartan 8mg, 16 mg 1x sehari Telmisartan 40mg, 80mg 1x sehari 3. Beta blocker Bisoprolol 2,5 mg, 5mg 1xsehari Carvedilol 3,125mg, 6,25mg 2x sehari 4. Antagonis aldosteron Spironolacton 25mg, 50mg 1x sehari Terapi ARNI, ivabradine, diberikan sesuai kondisi pasien
9	Edukasi	Edukasi tentang 1. Definisi gagal jantung 2. Terapi farmakologi 3. Diet: rendah garam, diet sesuai factor risiko dan penyakit co morbid misal DM, alcohol, merokok 4. Latihan: pastikan kembali olahraga yang nyaman untuk pasien. 5. Imunisasi influenza dan pneumococcal.
10	Prognosis	Prognosis gagal jantung tergantung pada : 1. Usia lanjut 2. Etiologi adalah iskemia/infark jantung 3. Hipotensi 4. NYHA grade III-IV 5. Penyakit Co morbid lain 6. EKG didapatkan: ventricular aritmia 7. Gangguan eltrolit 8. Left ventricle ejection fraction yang rendah
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap 1. Pasien sudah tidak sesak 2. Hemodinamik stabil 3. Tidak didapatkan tanda kongestive 4. Pasien dapat beraktifitas untuk kebutuhan minimal
14	Kepustakaan	ESC Guidelines For The Diagnosis And Treatment Of Acute And Chronic Heart Failure, 2016



PANDUAN PRAKTIK KLINIS HIPERTENSI		
1	Definisi	Diagnosis hipertensi ditegakkan bila TDS ≥ 140 mmHg dan/atau TDD ≥ 90 mmHg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Atau Dalam terapi obat anti hipertensi
2	Anamnesis	1. Riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya, riwayat minum obat anti hipertensi. 2. Riwayat keluarga hipertensi dan atau penyakit kardiovaskuler, Riwayat merokok, Diabetes melitus, obesitas, inaktivitas fisik, dislipidemia 3. Kepala terasa nyeri, berat, leher kaku terutama pagi hari bangun tidur 4. Dapat tanpa gejala
3	Pemeriksaan fisik	1. Hasil rata-rata pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal 2 kali tiap kunjungan, pada 2 kali kunjungan, dengan posisi duduk setelah beristirahat 5 menit adalah $\geq 140/90$ mmhg. 2. Jantung dalam batas normal atau ada pembesaran ventrikel kiri 3. Pemeriksaan fisik sesuai kerusakan target organ (gangguan jantung, retinopati, gangguan ginjal, gangguan otak)
4	Pemeriksaan penunjang	1. Darah rutin 2. Urin Rutin, 3. Ureum 4. Kreatinin, 5. Elektrolit Darah Na, K, Cl 6. Gula darah, 7. Profil lipid Pemeriksaan radiologi: 1. X foto thoraks Pemeriksaan lain: 1. EKG 2. Echocardiography (jika ditemukan kelainan jantung) 3. Funduskopi (jika ada indikasi)
5	kriteria Diagnosis	Diagnosis berdasarkan kriteria JNC 8



		<table> <tr> <th>BLOOD PRESSURE CLASSIFICATION</th><th>SBP MMHg</th><th>DBP MMHg</th></tr> <tr> <td>NORMAL</td><td><120</td><td>and <80</td></tr> <tr> <td>PREHYPERTENSION</td><td>120–139</td><td>or 80–89</td></tr> <tr> <td>STAGE 1 HYPERTENSION</td><td>140–159</td><td>or 90–99</td></tr> <tr> <td>STAGE 2 HYPERTENSION</td><td>≥160</td><td>or ≥100</td></tr> </table>	BLOOD PRESSURE CLASSIFICATION	SBP MMHg	DBP MMHg	NORMAL	<120	and <80	PREHYPERTENSION	120–139	or 80–89	STAGE 1 HYPERTENSION	140–159	or 90–99	STAGE 2 HYPERTENSION	≥160	or ≥100
BLOOD PRESSURE CLASSIFICATION	SBP MMHg	DBP MMHg															
NORMAL	<120	and <80															
PREHYPERTENSION	120–139	or 80–89															
STAGE 1 HYPERTENSION	140–159	or 90–99															
STAGE 2 HYPERTENSION	≥160	or ≥100															
6	Diagnosa Kerja	1. Hipertensi stage 1 2. Hipertensi stage 2															
7	Diagnosa Banding	Hipertensi sekunder															
8	Terapi	1. Terapi non farmakologi: - Diet rendah garam - Batasi intake cairan - Hentikan rokok, alcohol - Banyak makan sayur dan buah 2. Terapi farmakologi: - ACEI (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) - Captopril 12,5mg, 25mg, 50mg, 3x sehari atau - Lisinopril 5mg, 10mg 1x sehari atau - Ramipril 2.5mg, 5mg, 10mg 1x sehari atau - ARB (Angiotensin II Receptor Blocker) - Candesartan 8mg, 16 mg 1x sehari atau - Telmisartan 40mg, 80mg 1x sehari - Calcium channel blocker - Amlodipin 5mg, 10mg 1 x sehari atau - Diltiazem 30mg 3x sehari atau - Diltiazem lepas lambat 100mg, 200mg 1x sehari - Beta blocker - Bisoprolol 2,5 mg, 5mg 1xsehari atau - Carvedilol 3,125mg, 6,25mg 2x sehari - Diuretik - Thiazide 25 mg, 50mg 1xsehari atau - Spironolacton 25mg, 50mg 1x sehari Pemilihan jenis, dosis, dan kombinasi obat anti hipertensi menyesuaikan dengan <i>compelling indication</i> dan kondisi individu pasien															
9	Edukasi	Rutin minum obat Mematuhi terapi non farmakologi															
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam															



		Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang: Pasien telah mencapai target tekanan darah
14	Kepustakaan	Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia KonsensusPenatalaksanaan Hipertensi 2019



PANDUAN PRAKTIK KLINIS DIARE AKUT		
1	Definisi	- Perubahan pada frekuensi buang air besar menjadi lebih sering dari normal ATAU perubahan konsistensi feses menjadi lebih encer ATAU kedua-duanya dalam waktu kurang dari 14 hari. - Umumnya disertai dengan segala gangguan saluran cerna yang lain seperti mual, muntah dan nyeri perut, kadang-kadang disertai demam, darah pada feses serta tenesmus (gejala disentri).
2	Anamnesis	- Onset - Frekuensi - Kuantitas - Muntah - Adakah darah dan lender bercampur dalam feses - Riwayat traveling - Riwayat pengobatan antibiotik sebelumnya - Adanya penyakit yang mendasari misal: HIV/AIDS
3	Pemeriksaan fisik	- Penilaian tingkat kesadaran: compos mentis, apatis - Pemeriksaan fisik: - Periksa berat badan - Frekuensi jantung - Frekuensi napas, pola pernapasan - Tekanan darah - Suhu tubuh - Fisik abdomen: peristaltic usus - Tanda dehidrasi: - Kesadaran - Tekanan nadi - Hipotensi postural - Membrane mukosa kering - Mata cowong/cekung - Turgor kulit - Capillary refill - Produksi urine Klasifikasi dehidrasi secara klinis: - Dehidrasi ringan: kehilangan cairan 2-5% dari berat badan. Klinis: turgor kurang, suara serak, belum presyok - Dehidrasi ringan-sedang: kehilangan cairan 5-8% dari berat badan Klinis: turgor buruk, suara serak, keadaan bisa presyok/syok, nadi cepat, napas cepat dan dalam - Dehidrasi berat: kehilangan cairan > 8% dari berat badan



4	Pemeriksaan penunjang	1. Feses rutin 2. Kasus dengan dehidrasi dilakukan pemeriksaan darah rutin, feses dan urin rutin, kimia darah dan jika perlu analisis gas darah jika ada indikasi 3. Kultur feses (jika ada indikasi)
5	kriteria Diagnosis	Sesuai dengan definisi Indikasi Rawat inap jika: 1. Dehidrasi sedang sampai berat 2. Vomitus persisten 3. Diare yang memberat dalam 48 jam 4. Usia lanjut dan geriatri 5. Pasien dengan imunokompromais 6. Diare akut dengan komplikasi (misal gagal ginjal akut)
6	Diagnosa Kerja	Diare akut
7	Diagnosa Banding	Diare akut disertai demam dan tinja berdarah Diare akut tanpa disertai demam dan tinja berdarah
8	Terapi	Terapi Suportif: Rehidrasi cairan dan elektrolit sesuai dengan derajat dehidrasi. Jika pasien tanpa dehidrasi dapat dilakukan dengan upaya rehidrasi oral dengan oralit. Pada pasien dengan muntah menetap atau dengan dehidrasi sedang berat dilakukan terapi cairan intravena dengan cairan kristaloid (Ringer Lactate) Jumlah pemberian cairan: 1. berdasarkan klinis dehidrasi: a. Dehidrasi ringan: 5% x berat badan(kg) b. Dehidrasi sedang: 8% x berat badan (kg) c. Dehidrasi berat: 10% x berat badan (kg) Terapi simptomatis: 1. Antimotilitas : Loperamid, (4 mg awal dilanjutkan 2 mg tiap diare hingga maksimal 16 mg dalam 24 jam) 2. Pengeras feses : Attapulgit, Smektit, Kaolin-pektin (2 tablet tiap diare hingga maksimal 8 tablet dalam 24 jam) 3. Antiemetic Domperidone 10mg, Metoclopramide 10mg jika mual muntah 4. Antipiretik paracetamol 500mg jika demam Antibiotik jika diperlukan sesuai dengan indikasi
9	Edukasi	1. Higienitas makanan 2. Pembuatan oralit pada pasien rawat jalan 3. Tanda tanda dehidrasi pada pasien rawat jalan



10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap: 1. Hemodinamik stabil 2. Pasien sudah tidak mengeluhkan diare
14	Kepustakaan	1. World Gastroenterology Organisation Practice Guideline: Acute Diarrhea 2008 2. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi VI Bab Diare Akut. 2014



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PENYAKIT GINJAL KRONIK		
1	Definisi	- Kerusakan ginjal selama 3 bulan atau lebih, berupa kelainan struktur atau fungsi ginjal dengan atau tanpa disertai penurunan laju filtrasi glomerulus, berdasarkan : - Adanya kelainan patologik atau - Petanda kerusakan ginjal, termasuk kelainan pada komposisi darah atau urin, atau kelainan pada pemeriksaan pencitraan. - Laju filtrasi glomerulus (LFG) kurang dari 60ml/mnt/1,73m² selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal.
2	Anamnesis	- Lemas - Mual, - Muntah, - Buang air kecil berkurang, - Bengkak mata, kaki, atau seluruh tubuh, pucat, sesak nafas - Riwayat faktor risiko kerusakan ginjal: hipertensi, batu ginjal, DM, sakit jantung, peradangan ginjal. - Riwayat keluarga yang memiliki penyakit kista ginjal
3	Pemeriksaan fisik	- Konjungtiva anemis, - Kulit kering, - Edema palpebra, edema tungkai, asites - Hipertrofi ventrikel kiri - Pernafasan kusmaul (bila asidosis) - Ronki basah paru (bila overhidrasi)
4	Pemeriksaan penunjang	- Pemeriksaan laboratorium: - Darah lengkap - Urin Rutin, - Albumin Creatinin Ratio - Ureum - Kreatinin, - Elektrolit Darah Na, K, Cl, Ca, Mg, P Anorganik, - Albumin, Protein Total, - Glukosa plasma, - Serum besi, TIBC - Parathyroid hormon (jika ada indikasi) - Pemeriksaan radiologi: - USG abdomen, - Renogram - X foto thoraks - Pemeriksaan lain: EKG, Biopsi ginjal bila perlu



5	Kriteria Diagnosis	Berdasarkan LFG (dalam ml/mnt/1,73m²) $\frac{(140 - \text{umur}) \times \text{BB (kg)}}{72 \times \text{Serum kreatinin (mg/dl)}}$ wanita dikalikan 0,85 Klasifikasi : - Derajat 1 : LFG $\geq$ 90 ml/mnt/1,73m² - Derajat 2 : LFG 60-89 ml/mnt/1,73m² - Derajat 3 : LFG 30-59 ml/mnt/1,73m² - Derajat 4 : LFG 15-29 ml/mnt/1,73m² - Derajat 5 : LFG $\leq$ 15 ml/mnt/1,73m²
6	Diagnosa Kerja	Penyakit ginjal kronik
7	Diagnosa Banding	- Gangguan ginjal akut/acute kidney injury - Penyakit ginjal diabetika
8	Terapi	Terapi Non farmakologis : - Diet 35 kkal/kgBB/hari (KH 50%-60%; Lemak 30-40%), protein 0,6-0,8 gr/kgBB/hari - Diet rendah kalium sesuai dengan kadar elektrolit - Pembatasan asupan cairan sesuai kemampuan diuresis Terapi konservatif dengan medikamentosa pada PGK selain stadium IV dan V - Pada pasien PGK yang disebabkan oleh hipertensi maka beberapa golongan anti hipertensi menjadi pilihan terapi. Obat anti hipertensi (ACE-Inhibitor, Angiotensin-II Receptor Blocker, Calcium Channel Blocker) yang memiliki efek renoproteksi. ACE-inhibitor antara lain lisinopril 5-10 mg, ramipril 5-10 mg, perindopril 4-8 mg (dalam bentuk erbumine) / 5-10 mg (dalam bentuk arginine). ARB antara lain valsartan 80-160 mg, candesartan 8-16 mg, irbesartan 150-300 mg, telmisartan 40-80 mg. Calcium Channel Blocker antara lain amlodipine 5-10 mg, diltiazem 30-90 mg (sediaan diltiazem CD 100-200 mg) - Target Hb 10-12 g/dL (recombinant human erythropoietin/rhEPO bila untuk mempertahankan level hemoglobin 10 g/dL, transfusi PRC bila terdapat kontraindikasi rhEPO, kadar Hb < 7 g/dL) - Hiperfosfatemia diberikan calcium carbonate 3x1 tablet, atau calcium acetat 3x1 tablet, atau lanthanum carbonate 3x1 tablet - Acidosis dapat diberikan na bicarbonat - Bila ada overhidrasi dapat diberikan furosemide parenteral hingga dosis 2000 mg. - Acetylcystein parenteral diberikan dosis awal 150 mg/kgBB selama dua jam lewat syringe pump, selanjutnya diberikan dosis 50 mg/kgBB selama 4-6 jam lewat syringe pump - Suplementasi asam folat dan vitamin B12/cobalamin dapat diberikan

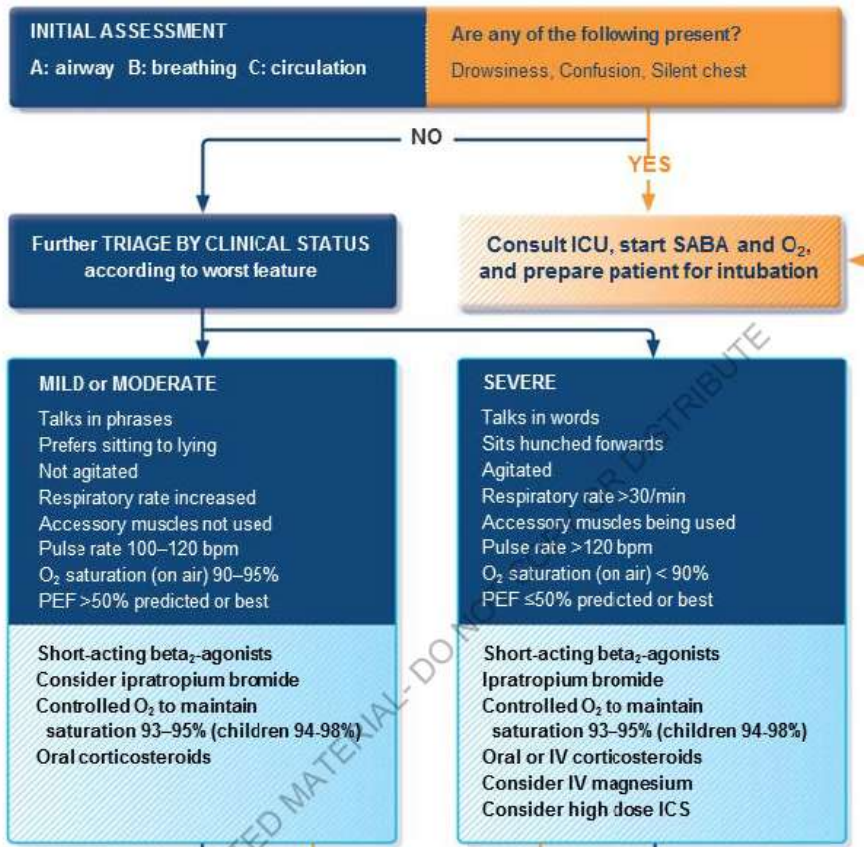


		pada pasien PGK yang disertai hyperhomocysteinemia
		Pada PGK stadium 4 dan 5 dilakukan terapi dialisis
9	Edukasi	1. Pada stadium awal diberitahu tentang faktor risiko progressifitas penyakit. 2. Diet dan minum obat teratur 3. Edukasi tentang dialisis
10	Prognosis	Prognosis sesuai dengan keparahan stadium gagal ginjal Stadium 1-3 ad bonam, stadium 4-5 ad malam Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungtionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (stadium 1-3) (Sesuai kompetensi dari kolegium) Level of competence 3A (stadium 4-5) (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat: 1. Tidak didapatkan tanda sindroma uremikum 2. Pasien telah mendapatkan jadwal dialisis (jika dilakukan hemodialisis)
14	Kepustakaan	Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi VI Bab Gagal Ginjal Kronik 2014



PANDUAN PRAKTIK KLINIS ASMA		
1	Definisi	Asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran napas yang berhubungan dengan peningkatan kepekaan saluran napas sehingga memicu episode mengi berulang, sesak napas dan batuk yang intensitasnya dapat berubah seiring waktu disertai dengan penurunan aliran udara ekspirasi.
2	Anamnesis	- Gejala berupa batuk, sesak napas, rasa berat di dada dan berdahak - Bersifat episodik, seringkali reversibel dengan atau tanpa pengobatan - Gejala timbul/ memburuk terutama malam/ dini hari - Diawali oleh faktor pencetus yang bersifat individu - Respons terhadap pemberian bronkodilator - Riwayat penyakit alergi di keluarga
3	Pemeriksaan fisik	- Gejala asma bervariasi sepanjang hari sehingga pemeriksaan jasmani dapat normal. - Pada serangan ringan, mengi hanya terdengar pada waktu ekspirasi paksa. - Pemeriksaan kesadaran - Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, laju respirasi, suhu, saturasi oksigen) - Pemeriksaan fisik paru didapatkan wheezing <i>Silent chest</i> pada serangan yang sangat berat, disertai sianosis, gelisah, sukar bicara, takikardi, hiperinflasi dan penggunaan otot bantu napas
4	Pemeriksaan penunjang	- Laboratorium darah: ditemukan eosinofilia - Spirometri - Jika ada indikasi dilakukan pemeriksaan EKG, foto thorax - Pemeriksaan test alergi (jika ada indikasi)
5	kriteria Diagnosis	- Pemeriksaan spirometri dalam diagnosis asma : - Rasio $VEP1/KVP < 75\%$ atau $VEP1 < 80\%$ nilai prediksi. - Reversibiliti, perbaikan $VEP1 \geq 12\%$ dan 200 ml secara spontan, atau setelah inhalasi bronkodilator (uji bronkodilator), atau setelah pemberian bronkodilator oral 10-14 hari, atau setelah pemberian kortikosteroid (inhalasi/ oral) 2 minggu. - Arus Puncak Ekspirasi (APE) <i>Reversibiliti</i>, yaitu perbaikan nilai $APE \geq 15\%$ setelah inhalasi bronkodilator (uji bronkodilator), atau bronkodilator oral 10-14 hari, atau respons terapi kortikosteroid (inhalasi/ oral, 2 minggu) <i>Variabiliti</i>, menilai variasi diurnal APE yang dikenal dengan variabiliti APE harian selama 1-2 minggu.



6	Diagnosa Kerja	Asthma terkontrol/tidak terkontrol dengan serangan eksaserbasi ringan sedang berat
7	Diagnosa Banding	Penyakit Paru Obstruksi Kronik Bronkitis kronik Gagal Jantung Kongestif Batuk kronik akibat lain-lain Disfungsi laring Obstruksi mekanis (misal tumor)
8	Terapi	Terapi disesuaikan dengan tingkat kontrol dan beratnya exacerbasi serangan 1. Alur tatalaksana asma exacerbasi di gawat darurat  <pre> graph TD A["INITIAL ASSESSMENT A: airway B: breathing C: circulation"] --> B1["Are any of the following present? Drowsiness, Confusion, Silent chest"] B1 -- NO --> B2["Further TRIAGE BY CLINICAL STATUS according to worst feature"] B1 -- YES --> B3["Consult ICU, start SABA and O2, and prepare patient for intubation"] B2 --> B4["MILD or MODERATE Talks in phrases Prefers sitting to lying Not agitated Respiratory rate increased Accessory muscles not used Pulse rate 100–120 bpm O2 saturation (on air) 90–95% PEF >50% predicted or best"] B2 --> B5["SEVERE Talks in words Sits hunched forwards Agitated Respiratory rate >30/min Accessory muscles being used Pulse rate >120 bpm O2 saturation (on air) < 90% PEF ≤50% predicted or best"] B4 --> B6["Short-acting beta2-agonists Consider ipratropium bromide Controlled O2 to maintain saturation 93–95% (children 94-98%) Oral corticosteroids"] B5 --> B7["Short-acting beta2-agonists Ipratropium bromide Controlled O2 to maintain saturation 93–95% (children 94-98%) Oral or IV corticosteroids Consider IV magnesium Consider high dose ICS"] </pre> 2. Alur tatalaksana asma rawat jalan

		Adults & adolescents 12+ years Personalized asthma management: Assess, Adjust, Review response Symptoms Exacerbations Side effects Lung function Patient satisfaction Asthma medication options: Adjust treatment up and down for individual patient needs STEP 1 As-needed low dose ICS-formoterol* STEP 2 Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS), or as-needed low dose ICS-formoterol* STEP 3 Low dose ICS-LABA STEP 4 Medium-dose ICS-LABA STEP 5 High dose ICS-LABA Other controller options: Other controller options Other reliever options: Other reliever options Macam macam terapi asma (Pemilihan disesuaikan dengan tingkat terkontrolnya asma): 1. Budesonide inhaler 100mcg, 200mcg/dosis 2. Budesonide 0,25mg dan 0,5mg /ml 3. Fluticasone propionat 0,5mg/dosis 4. Prokaterol 10mcg 5. Salbutamol tab 2mg, 4 mg 6. Salbutamol sirup 2mg/5ml 7. Salbutamol nebulasi 0,1 % 2,5 ml 8. Prokaterol sirup 5mcg/ml 9. Fenoterol 100mcg/puff 10. Terbutalin tab 2,5mg 11. Terbutalin inhalasi 2,5mg/ml 12. Ipratropium Bromide 13. Tiotropium bromide 14. Montelukast Kombinasi: 1. Budesonid dan Formoterol 2. Ipratropium bromida 0,5 mg + Salbutamol 2,5 mg 3. Salmeterol 50 mcg, Flutikason Propionat 100 mcg
9	Edukasi	1. Tentang penyakitnya, pencetus serangan dan cara mengatasi serangan akut 2. Pencegahan eksaserbasi 3. Menjaga fungsi paru terutama saat exercise
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A(Sesuai kompetensi dari kolegium)

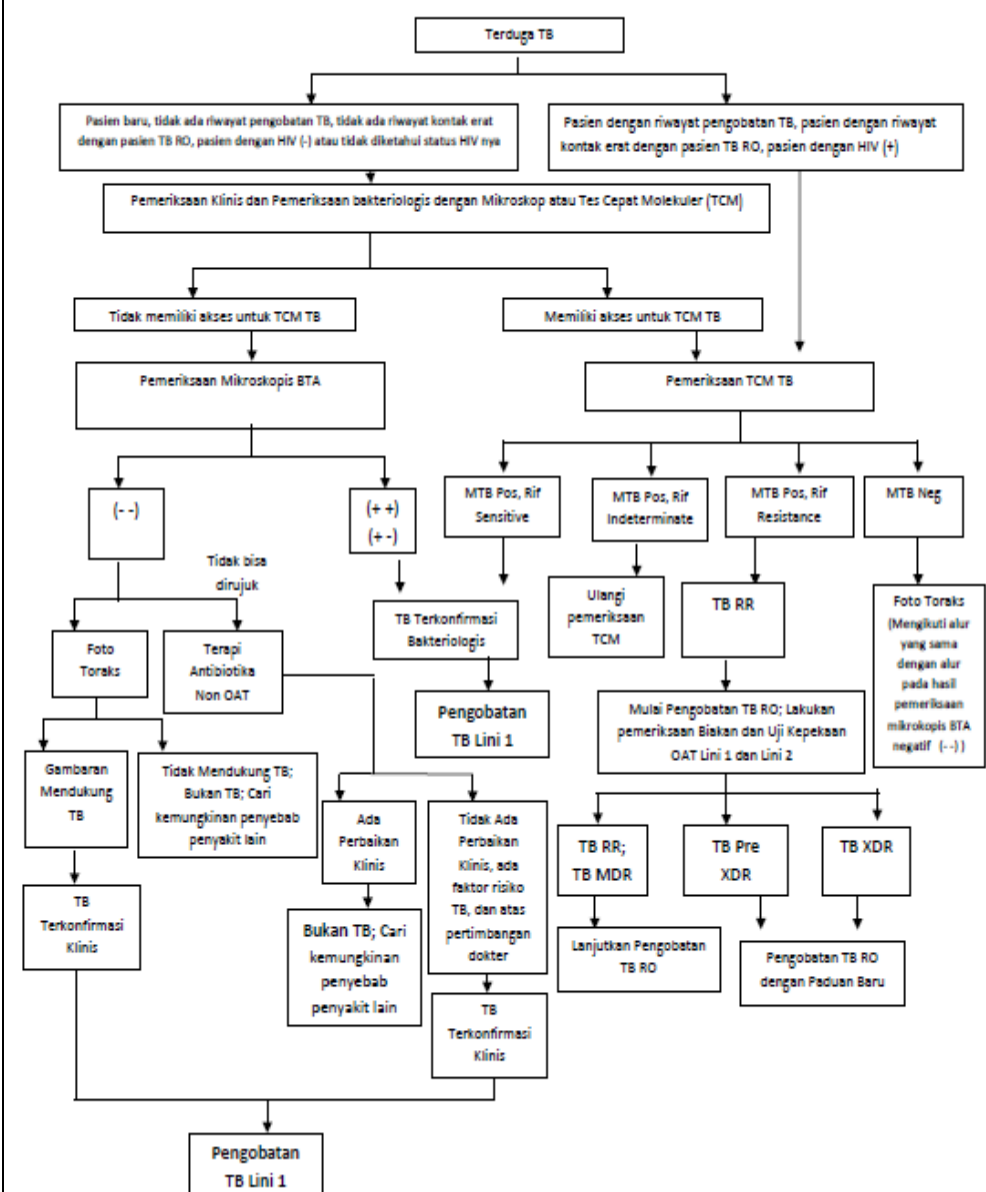


12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap: 1. Hemodinamik stabil 2. Sudah tidak didapatkan tanda dan gejala asma
14	Kepustakaan	Global Initiative For Asthma 2019



PANDUAN PRAKTIK KLINIS TUBERKULOSIS		
1	Definisi	Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (MTb). Sebagian besar kuman MTb menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.
2	Anamnesis	- Gejala respiratorik : batuk ≥ 2 minggu, batuk darah, sesak napas, nyeri dada - Gejala sistemik: demam, malaise, keringat malam, anoreksia, berat badan menurun - Gejala tuberkulosis ekstra paru sesuai organ yang terkena. - Anamnesis juga perlu dilakukan untuk memperkirakan sumber penularan, kondisi sosio ekonomi, serta kemungkinan penyakit komorbid yang bisa menyebabkan terkena infeksi kuman TBC
3	Pemeriksaan fisik	- Pengukuran status gizi dengan antropometri - Pemeriksaan kelenjar getah bening - Pemeriksaan Kelainan paru pada umumnya terletak di daerah lobus superior terutama daerah apeks dan segmen posterior (S1 & S2) , serta daerah apeks lobus inferior (S6) berupa suara napas bronkial, amforik, suara napas melemah, ronki basah, tanda-tanda penarikan paru, diafragma & mediastinum. - Pemeriksaan organ lain yang dicurigai sesuai dengan TB extra Paru
4	Pemeriksaan penunjang	Laboratorium: - Darah lengkap - AST dan ALT: di periksa sebelum pengobatan untuk penilaian efek samping obat - Pemeriksaan Tes Cepat Molekular TB - Pemeriksaan dahak mikroskopik langsung, dengan mengumpulkan dahak sewaktu – pagi - Pemeriksaan anti-HIV yang dapat menjadi penyakit ko-morbid - Pemeriksaan glukosa plasma (DM merupakan penyakit ko-morbid) Pemeriksaan penunjang radiologi: - X ray thorax: caverne, bercak awan/perselubungan homogen di apex paru - Pemeriksaan lain yang sesuai jika ada indikasi Pemeriksaan spesimen lain sesuai dengan indikasi (cairan pleura, asites, biopsi jaringan)
5	Kriteria Diagnosis	- Pasien dengan gejala klinis: Batuk lebih dari 2 minggu atau gejala respirasi lain seperti sesak, batuk darah, nyeri dada disertai dengan gejala sistemik seperti penurunan nafsu makan, keringat malam, lemah, demam - Radiologi yang sesuai dengan gambaran TB - Pemeriksaan bakteriologis dengan menggunakan test cepat molekular dan atau pemeriksaan mikroskopis Alur diagnosis pasien Tuberkulosis paru dewasa



		Alur diagnosis TB dan TB Resistan Obat di Indonesia 
6	Diagnosa Kerja	Tuberkulosis paru (TB Terkonfirmasi Klinis; TB Terkonfirmasi Bakteriologis)
7	Diagnosa Banding	1. Bronchopneumonia 2. Pneumonia atipikal 3. Karsinoma paru
8	Terapi	Terapi non farmakologi: 1. Diet tinggi kalori tinggi protein 2. Perbaikan keadaan umum 3. Pemberian obat simtomatis (sesuai keadaan pasien) Terapi farmakologi: OAT lini pertama adalah Rifampisin, Pirazinamid, Isoniazid,

		Etambutol dan Streptomisin Paduan OAT yang digunakan : 1) Kategori 1 : 2(HRZE) / 4(HR)3 atau 2(HRZE) / 4(HR)																																																																						
		<table><tr><th rowspan="2">Obat</th><th rowspan="2">Dosis (Mg/Kg BB/Hari)</th><th colspan="2">Dosis yg dianjurkan</th><th rowspan="2">DosisMaks (mg)</th><th colspan="3">Dosis (mg) / berat badan (kg)</th></tr><tr><th>Harian (mg/ kgBB / hari)</th><th>Intermitte (mg/Kg/ BB/kali)</th><th>< 40</th><th>40-60</th><th>>60</th></tr><tr><td>R</td><td>8-12</td><td>10</td><td>10</td><td>600</td><td>300</td><td>450</td><td>600</td></tr><tr><td>H</td><td>4-6</td><td>5</td><td>10</td><td>300</td><td>150</td><td>300</td><td>450</td></tr><tr><td>Z</td><td>20-30</td><td>25</td><td>35</td><td></td><td>750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr><tr><td>E</td><td>15-20</td><td>15</td><td>30</td><td></td><td>750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr><tr><td>S</td><td>15-18</td><td>15</td><td>15</td><td>1000</td><td>Sesuai BB</td><td>750</td><td>1000</td></tr></table> Atau menggunakan obat bentuk kombinasi dosis tetap (KDT) <table><tr><th rowspan="2">Berat Badan</th><th>Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275)</th><th>Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>30 – 37 kg</td><td>2 tablet 4KDT</td><td>2 tablet 2KDT</td></tr><tr><td>38 – 54 kg</td><td>3 tablet 4KDT</td><td>3 tablet 2KDT</td></tr><tr><td>55 – 70 kg</td><td>4 tablet 4KDT</td><td>4 tablet 2KDT</td></tr><tr><td>≥ 71 kg</td><td>5 tablet 4KDT</td><td>5 tablet 2KDT</td></tr></table> 2) Kategori 2 : 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3 atau 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)E	Obat	Dosis (Mg/Kg BB/Hari)	Dosis yg dianjurkan		DosisMaks (mg)	Dosis (mg) / berat badan (kg)			Harian (mg/ kgBB / hari)	Intermitte (mg/Kg/ BB/kali)	< 40	40-60	>60	R	8-12	10	10	600	300	450	600	H	4-6	5	10	300	150	300	450	Z	20-30	25	35		750	1000	1500	E	15-20	15	30		750	1000	1500	S	15-18	15	15	1000	Sesuai BB	750	1000	Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275)	Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150)			30 – 37 kg	2 tablet 4KDT	2 tablet 2KDT	38 – 54 kg	3 tablet 4KDT	3 tablet 2KDT	55 – 70 kg	4 tablet 4KDT	4 tablet 2KDT	≥ 71 kg	5 tablet 4KDT	5 tablet 2KDT
Obat	Dosis (Mg/Kg BB/Hari)	Dosis yg dianjurkan			DosisMaks (mg)	Dosis (mg) / berat badan (kg)																																																																		
		Harian (mg/ kgBB / hari)	Intermitte (mg/Kg/ BB/kali)	< 40		40-60	>60																																																																	
R	8-12	10	10	600	300	450	600																																																																	
H	4-6	5	10	300	150	300	450																																																																	
Z	20-30	25	35		750	1000	1500																																																																	
E	15-20	15	30		750	1000	1500																																																																	
S	15-18	15	15	1000	Sesuai BB	750	1000																																																																	
Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275)	Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150)																																																																						
30 – 37 kg	2 tablet 4KDT	2 tablet 2KDT																																																																						
38 – 54 kg	3 tablet 4KDT	3 tablet 2KDT																																																																						
55 – 70 kg	4 tablet 4KDT	4 tablet 2KDT																																																																						
≥ 71 kg	5 tablet 4KDT	5 tablet 2KDT																																																																						
9	Edukasi	1. Etika batuk: tidak buang dahak sembarangan 2. Istirahat dengan nutrisi yang adekuat 3. Minum obat teratur, tidak boleh putus.																																																																						
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam																																																																						
11	Kompetensi	Level of competence 4A(Sesuai kompetensi dari kolegium)																																																																						
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi																																																																						
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap 1. Tidak ditemukan efek samping OAT yang berat 2. Tidak didapatkan gangguan pernapasan yang mendadak (pneumotoraks) 3. Pasien bersedia menjalani pengobatan rutin selama 6 bulan atau 8 bulan																																																																						
14	Kepustakaan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 2. Perhimpunan Respirologi Dan Penyakit Kritis Indonesia Modul PPM TB PAPDI 2017																																																																						
PANDUAN PRAKTIK KLINIK PNEUMONIA BAKTERI KOMUNITAS																																																																								
1	Definisi	Pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme (pada PPK ini terbatas infeksi bakteri)																																																																						
2	Anamnesis	1. Mengeluhkan demam, sesak napas, batuk dahak warna kuning ke hijauan. Dapat disertai dengan nyeri dada. 2. Anamnesis terkait penyakit comorbid lain. 3. Anamnesis terkait penggunaan antibiotik dalam 90 hari terakhir.																																																																						



3	Pemeriksaan fisik	1. Kesadaran 2. Tanda vital (tekanan darah, laju respirasi, denyut nadi, suhu) 3. Pemeriksaan fisik paru: penggunaan otot bantu napas, pengembangan paru, stem fremitus, perkusi redup, suara napas dasar bronkial, suara napas tambahan ronki.
4	Pemeriksaan penunjang	1. Laboratorium darah lengkap: leukositosis atau leukopenia 2. Pemeriksaan bun, creat, GDS 3. Pemeriksaan Analisa gas darah (Jika ada indikasi) 4. Kultur sputum (jika ada indikasi) 5. Sputum BTA (jika ada indikasi) 6. Pemeriksaan Ro thorax
5	Kriteria Diagnosis	Diagnosis berdasarkan kondisi klinik yang sesuai dengan pneumonia; demam, sesak, batuk purulen. Disertai dengan gambaran ro thorax yang menyokong untuk pneumonia.
6	Diagnosa Kerja	Pneumonia bakterial komunitas
7	Diagnosa Banding	1. Asma 2. PPOK 3. Gagal jantung kronik
8	Terapi	1. Terapi non farmakologi: a. Tirah baring b. Cukupi cairan dan kalori c. Oksigenasi sesuai saturasi 2. Terapi farmakologi: a. Terapi simptomatis sesuai kondisi pasien b. Terapi Antibiotik empirik untuk kuman pneumonia komunitas: Pasien dewasa rawat jalan yang sehat tanpa komorbiditas yang atau faktor risiko untuk patogen resisten antibiotik. 1. amoksisilin 1 g tiga kali sehari, atau doksisisiklin 100 mg dua kali sehari, atau makrolida (azitromisin 500 mg 1x sehari atau klaritromisin 500 mg dua kali sehari) Pasien dewasa rawat jalan dengan komorbiditas seperti jantung kronis, paru-paru, hati, atau penyakit ginjal; diabetes mellitus; alkoholisme; keganasan; atau splenia: Terapi kombinasi: 1. amoxicillin/clavulanate 500 mg/125 mg 3x sehari, atau 2. amoxicillin/ clavulanate 875 mg/125 mg, or 2,000 mg/125 mg 2 xsehari, atau 3. cephalosporin (cefepodoxime 200 mg 2x seharior cefuroxime 500 mg 2xsehari); dan 4. macrolide (azithromycin 500 mg 1x sehari atau clarithromycin 500 mg 2x sehari Monoterapi:



		1. fluoroquinolone pernapasan (levofloxacin 750 mg 1x se hari, atau 2. moxifloxacin 400 mg 1x se hari,) Pada orang dewasa rawat inap dengan CAP tidak parah tanpa faktor risiko untuk MRSA atau P. aeruginosa: 1. Terapi kombinasi dengan b-laktam (ampicillin/sulbactam 1,5-3 g setiap 6 jam, sefotaksim 1-2 g setiap 8 jam, seftriakson 1-2 g setiap hari, DAN makrolida (azitromisin 500 mg setiap hari atau klaritromisin 500 mg dua kali sehari) Atau 2. Monoterapi dengan: fluoroquinolone pernapasan (levofloxacin 750 mg setiap hari, moxifloxacin 400 mg setiap hari) Pasien dewasa rawat inap dengan CAP parah: 3. b-laktam plus makrolida atau b-laktam plus fluoroquinolone pernapasan Terapi tersebut merupakan terapi empirik yang berubah jika kultur sensitifitas kuman definitif sudah didapatkan Terapi diberikan hingga waktu 5 hari atau menyesuaikan keadaan klinis pasien.
9	Edukasi	1. Etika batuk: tidak buang dahak sembarangan 2. Istirahat dengan nutrisi yang adekuat 3. Minum obat teratur, tidak boleh putus.
10	Prognosis	Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungsionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A(Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap 1. Keadaan hemodinamik stabil 2. Tidak didapatkan distress pernapasan
14	Kepustakaan	1. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):E45–67. 2. Sharma S, Sharma P, Tyler LN. Transfusion of blood and blood products: Indications and complications. Am Fam Physician. 2011;83(6):719–24.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS ANEMIA		
1	Definisi	Anemia adalah keadaan menurunnya kadar Hemoglobin dibawah normal yang disebabkan banyak faktor. Misal defisiensi, hemolitik, gangguan sumsum tulang serta gangguan lain nya
2	Anamnesis	Pasien mengeluhkan lemas, mudah lelah. Keadaan yang lebih berat pasien dapat mengalami nyeri dada, dada berdebar, gangguan kesadaran. Anamnesis lanjutan mencari faktor penyebab dari anemia. Misal: 1. Perdarahan kronik/ akut 2. Defisiensi asupan mikro nutrien 3. Gangguan sumsum tulang (mimisan, sering demam, organomegali dll) 4. Hemolitik (ikterus, BAK berubah warna) 5. Gangguan ginjal (kencing berkurang, bengkak) 6. Penyakit kronis lainnya
3	Pemeriksaan fisik	1. Kesadaran 2. Tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, laju respirasi, suhu) 3. Konjungtiva pucat 4. Atropi papil lidah 5. Stomatitis angularis 6. Pembesaran kelenjar limfe 7. Organomegali 8. Kuku sendok 9. Kapilary refill 10. Sumber perdarahan
4	Pemeriksaan penunjang	1. Hemoglobin 2. MCV 3. MCH 4. MCHC 5. Retikulosit 6. Pemeriksaan laboratorium spesifik sesuai indikasi (misal profil besi, fungsi ginjal dll) 7. Pemeriksaan morfologi darah tepi dan aspirasi sumsum tulang sesuai indikasi
5	Kriteria Diagnosis	Berdasar kan WHO Laki laki: < 13g/dl Wanita < 12 g/dl
6	Diagnosa Kerja	Anemia
7	Diagnosa Banding	1. Anemia defisiensi 2. Anemia perdarahan 3. Anemia penyakit kronik 4. Anemia gangguan sumsum tulang



8	Terapi	Terapi sesuai dengan penyakit dasarnya misal: 1. Defisiensi besi diberikan sulfas ferosus 3x200mg selama 3 bulan 2. Anemia akibat keganasan hematologi dilakukan kemoterapi 3. Anemia akibat Thallasemia diberika tranfusi 4. Anemia akibat perdarahan dilakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan Tranfusi diberikan pada indikasi: 1. Anemia dengan simtomatik (misal lemas, sesak napas, palpitasi dll) 2. Anemia dengan Hb < 7g/dl Pemilihan jenis tranfusi disesuaikan dengan kondisi klinis pasien.
9	Edukasi	Perjalanan penyakit anemia sesuai penyakit dasar
10	Prognosis	Sesuai dengan penyakit dasar Ad vitam : ad bonam Ad sanationam : ad bonam Ad fungtionam : ad bonam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	Kesesuaian dokter dalam melakukan terapi
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Kriteria pasien pulang rawat inap 1. Hb > 10g/dl atau sesuai target penatalaksanaan penyakit dasar dan komorbid 2. Tidak ada tanda dan gejala anemia
14	Kepustakaan	1. John W. Adamson., 2015. Hematopoetic disorder In: Kasper, D, Fauci, L., Longo, L., Jameson, L., Loscalzo, J., <i>et al</i> (Editors) <i>Harrison's Principles of Internal Medicine, the 19th edition</i>, The McGraw-Hill Companies, Chapter 126. 2. Sharma S, Sharma P, Tyler LN. Transfusion of blood and blood products: Indications and complications. <i>Am Fam Physician</i>. 2011;83(6):719–24.



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PERDARAHAN SALURAN CERNA BAGIAN BAWAH (Hematochezia)		
1	Definisi	Perdarahan saluran cerna di sebelah distal ligamentum Treitz. Meliputi perdarahan dari usus halus dan usus besar
2	Anamnesis	a. Sejak kapan terjadi perdarahan b. Riwayat perdarahan sebelumnya c. BAB darah atau BAB hitam d. Apakah disertai diare atau nyeri perut e. Riwayat dilakukan endoskopi f. Obat-obatan yang diminum sebelumnya g. Adakah penurunan berat badan
3	Pemeriksaan fisik	a. Pemeriksaan tanda vital (adakah takikardia, hipotensi, singkop) b. Pemeriksaan kardiopulmoner, respirasi, dan abdomen c. Pemeriksaan rectum secara digital (<i>rectal toucher</i>)
4	Pemeriksaan penunjang	a. Pemeriksaan darah lengkap, elektrolit serum, tes koagulasi, albumin, kreatinin b. Kolonoskopi
5	Kriteria Diagnosis	a. Anamnesis : buang air besar warna merah terang b. Pemeriksaan fisik : pemeriksaan <i>rectal toucher</i> terdapat darah pada feses c. Laboratorium : anemia d. Kriteria Imaging (CT angiografi atau Kolonoskopi) : sumber perdarahan pada kolon atau rektum
6	Diagnosa Kerja	Perdarahan Saluran Cerna Bagian Bawah
7	Diagnosa Banding	a. <i>Benigna</i> : divertikel, kelainan rectum (hemoroid, fisura ani, proktitis radiasi, ulkus rektum, trauma, prolapse rekti), kelainan vaskuler (angiektasis, <i>Dieulafoy's lesion</i>, varises kolon atau rectum), kolitis (<i>Inflammatory bowel disease</i>, iskemik, infeksi, <i>undetermined</i>), polip, iatrogenic (post polipektomi, dll) b. <i>Maligna</i> : kanker kolorektal, kanker anus, lesi metastase/<i>invasive</i>
8	Terapi	a. Resusitasi hemodinamik b. Tranfusi darah jika $Hb \leq 7$ (tanpa penyakit kardiovaskuler) dengan target Hb 7-9 g/dL, sedangkan untuk yang disertai dengan penyakit kardiovaskuler target transfusi jika $Hb \leq 8$ dengan target $Hb \geq 10$ g/dL c. Menghentikan perdarahan sesuai etiologi perdarahan saluran cerna bagian bawah d. Embolisasi arteri yang menimbulkan perdarahan dengan tuntunan



		radiologi
9	Edukasi	Modifikasi perilaku untuk mencegah atau memperlambat progresi penyakit, mencakup: - Diet tinggi serat - Kurangi konsumsi daging - Rajin berolahraga
10	Prognosis	Dubia ad malam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	- Penegakan diagnosis: 2 hari. - Lama terapi: 5 hari (kecuali disertai pemberatan komorbid lain).
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	- Gejala klinis membaik, intake oral baik, tidak ada pemberatan komorbid lain. - Kriteria laboratorium membaik
14	Kepustakaan	- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology 2018. - Siti Nurdjanah. Sirosis Hati. In : Sudoyo A, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. Buku ajar ilmu penyakit dalam. 4th ed. Jakarta; Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2014:1963-1971



PANDUAN PRAKTIK KLINIS PERDARAHAN SALURAN Cerna BAGIAN ATAS		
1	Definisi	Perdarahan saluran cerna di sebelah proksimal ligamentum Treitz. Dibedakan menjadi perdarahan variseal dan non-variseal
2	Anamnesis	a. Sejak kapan dan banyaknya perdarahan b. Riwayat perdarahan sebelumnya c. Riwayat pemakaian obat sebelumnya d. Riwayat perdarahan pada keluarga e. Riwayat penyakit hati kronik
3	Pemeriksaan fisik	a. Stigmata penyakit hati kronik b. Suhu badan dan perdarahan di tempat lain c. Kelainan kulit dan mukosa
4	Pemeriksaan penunjang	a. Uji laboratorium umum: Darah perifer lengkap, fungsi hemostasis, fungsi hati, kimia darah ~ hemodinamik, koagulasi rutin (PPT, PTTK, INR), b. Imaging : Ro toraks, USG Abdomen c. Endoskopi
5	Kriteria Diagnosis	a. Anamnesis : muntah darah atau muntah kehitaman, riwayat minum NSAID, riwayat penyakit hati b. Pemeriksaan fisik : tanda stigmata penyakit hati kronik dan hipertensi porta c. Laboratorium : anemia, leukositosis, trombositopenia, tes fungsi hati menunjukkan gambaran sirosis hepatis. d. Kriteria Imaging (USG Abdomen, MSCT Abdomen) : gambaran sirosis
6	Diagnosa Kerja	Perdarahan saluran cerna bagian atas
7	Diagnosa Banding	Non Variseal : a. Ulkus gaster b. Ulkus duodenum c. Mallory Weiss Tears d. Erosi/ gastropathy gaster e. Esofagitis f. Lesi Dieulafoy g. Telangiectasis h. GAVE (<i>Gastric antral vascular ectasia</i>) i. Neoplasma Variseal : a. Varises esofagus



		b. Gastropathy hipertensi portal c. Varises gaster
8	Terapi	a. Stratifikasi risiko dan penatalaksanaan kegawatan : cairan kristaloid, koloid, transfusi darah Perdarahan non variseal : 1)PPI (lansoprasol, omeprazol) IV bolus atau continous 2)Injeksi vitamin K 3)Antibiotika empiris b. Perdarahan karena ruptur varises esofagus 1) Puasa sampai dengan 8 jam bebas melenas 2) Vasoaktif selama 3-5 hari, yaitu somatostatin 250 mikrogram bolus dilanjutkan dengan 250 mikrogram/jam atau oktreotid 50 mikrogram bolus dilanjutkan 50 mikrogram/jam 3) Esofagogastroduodenoskopi (ligasi varises esofagus) jika kondisi hemodinamik stabil. 4) Antibiotika profilaksis dengan injeksi Ceftriaxon 1 gram/24 jm intravena c. Untuk perdarahan yang tidak tampak melalui endoskopi dapat dilakukan embolisasi arteri yang menimbulkan perdarahan dengan tuntunan radiologi
9	Edukasi	Modifikasi perilaku untuk mencegah atau memperlambat progresi penyakit, mencakup: a. Penghentian konsumsi alkohol b. Penghentian NSAID c. Rutin minum obat
10	Prognosis	Dubia ad malam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	a. Penegakan diagnosis: 2 hari b. Lama terapi: 5 hari (kecuali disertai pemberatan komorbid lain)
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	a. Gejala klinis membaik, intake oral baik, tidak ada perdarahan lagi. b. Kriteria laboratorium membaik
14	Kepustakaan	1. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology 2018 2. Setiati S, Alwi I, Sudoyo A, Simadibrata M, Setiyohadi B, Syam A. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. 6th ed. Vol. 1. Jakarta: Interna Publishing; 2014 3. Mujtaba S, Chawla S and Massaad JF. Diagnosis and Management of Non-Variceal Gastrointestinal Hemorrhage: A Review of Current Guidelines and



		Future Perspectives. J. Clin. Med. 2020.
--	--	--



PANDUAN PRAKTIK KLINIS SIROSIS HEPATIS		
1	Definisi	Tahap akhir proses fibrosis hati yang luas dan progresif yang ditandai oleh distorsi arsitektur hati dan pembentukan nodul regeneratif
2	Anamnesis	Sirosis kompensata : sebagian besar asimtomatik Sirosis dekompensata : a. Gejala non spesifik: anoreksia, penurunan berat badan, kelemahan, kelelahan b. Kebingungan akibat ensefalopati hepatikum c. Pruritus, jaundice d. Distensi abdomen / ascites e. Gejala perdarahan saluran cerna (hematemesis, mele-na, hematochezia) f. Kram otot g. Amenorrhea h. Impotensi, gangguan seksual
3	Pemeriksaan fisik	a. Umum : muscle wasting b. Sistem saraf pusat : asterixis, ensefalopati hepatikum dalam berbagai derajat c. Kepala : fetor hepaticus, sklera ikterik d. Thorax : ginekomastia, spider nevi, rambut aksila rontok e. Abdomen : spider nevi, ascites, caput medusae, hemorrhoid, pengecilan liver, splenomegali, venektasi dinding abdomen f. Tangan dan kuku : kontraktur Dupuytren, eritema palmar, perubahan kuku (Muerche's lines, Terry's nails, clubbing) g. Genitourinari : atrofi testis h. Ekstremitas bawah : eritema palmaris, edema
4	Pemeriksaan penunjang	a. Uji laboratorium umum: Darah perifer lengkap, ALT, AST, Gamma GT, alkalin fosfatase, bilirubin total, bilirubin direk, protein total, albumin, globulin, studi koagulasi rutin (PPT, PTTK, INR) b. Imaging : USG Abdomen, MSCT Abdomen, operasi anti refluks atau mengevaluasi NERD berulang setelah operasi anti refluks.
5	Kriteria Diagnosis	a. Kriteria Klinis : tanda stigmata penyakit hati kronik dan hipertensi porta b. Kriteria Laboratorium : trombositopenia, Tes Fungsi Hati menunjukkan gambaran sirosis hepatis c. Kriteria Imaging (USG Abdomen, MSCT Abdomen) : gambaran sirosis
6	Diagnosa Kerja	Sirosis Hepatis



7	Diagnosa Banding	a. Hipertensi Porta Non Sirotik b. Karsinoma Hepatoseluler c. Hepatitis Kronik d. Acute on Chronic Liver Failure (ACLF)
8	Terapi	a. Menghentikan/menghilangkan etiologi : anti viral, stop alkohol b. Terapi diberikan berdasarkan tanda dan komplikasi yang timbul : 1) Ascites a) Diit rendah garam b) Spironolakton (dosis 100 - 400 mg/hari), bila respon tidak adekuat dikombinasikan dengan furosemid (40-160 mg/hari) c) Parasintesis terapeutik bila ascites sangat besar d) Restriksi cairan direkomendasikan jika natrium serum <120-125 mmol/L 2) Ensefalopati hepatikum a) Laktulosa dosis : 15-20 ml/12 jam po b) BCAA oral c) LOLA infus 3) Ruptur Varises Esofagus a) Puasa sampai dengan 8 jam bebas melena b) Vasoaktif selama 3-5 hari, yaitu somatostatin 250 mikrogram bolus dilanjutkan dengan 250 mikrogram/jam atau oktreotid 50 mikrogram bolus dilanjutkan 50 mikrogram/jam atau terlipresin c) Esofagogastroduodenoskopi (Ligasi varises esofagus) jika kondisi hemodinamik stabil. d) Antibotika profilaksis dengan injeksi Ceftriaxon 1 gram/24 jm intravena 4) Peritonitis bakterial spontan a) Norfloxacin 400 mg/hari per oral atau Ciprofloxacin 400 mg/12 jam intravena atau Injeksi Cefotaksim 1 gram/8 jam intravena
9	Edukasi	Modifikasi perilaku untuk mencegah atau memperlambat progresi penyakit, mencakup: a. Penghentian konsumsi alkohol b. Intervensi diet (diit rendah garam) c. Rutin kontrol ke dokter. d. Rutin minum obat
10	Prognosis	Dubia ad malam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)



12	Indikator medis	a. Penegakan diagnosis: 2 hari. b. Lama terapi: 5 hari (kecuali disertai pemberatan komorbid lain).
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	a. Gejala klinis membaik, intake oral baik, tidak ada pemberatan komorbid lain. b. Kriteria laboratorium membaik
14	Kepustakaan	a. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology 2018. b. Siti Nurdjanah. Sirosis Hati. In : Sudoyo A, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. Buku ajar ilmu penyakit dalam. 4th ed. Jakarta; Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2014:1963-1971



PANDUAN PRAKTIK KLINIS DIARE KRONIS		
1	Definisi	Keluarnya feses cair atau peningkatan frekuensi buang air besar disertai perut terasa tidak nyaman, yang berlangsung lebih dari 15 hari
2	Anamnesis	a. Darah pada feses b. Demam c. Penurunan berat badan d. Onset pada usia ≥ 50 tahun e. Riwayat keluarga dengan polip atau kanker kolorektal f. Diare tetap terjadi walaupun puasa g. Feses dengan volume besar atau steatorhea
3	Pemeriksaan fisik	a. Pucat b. Hepatosplenomegali c. Pembesaran kelenjar limfa d. Massa abdomen
4	Pemeriksaan penunjang	a. Uji laboratorium : Darah perifer lengkap, ALT, AST, Gamma GT, alkaline fosfatase, bilirubin total, bilirubin direk, protein total, albumin, globulin, studi koagulasi rutin (PPT, PTTK, INR), gula darah, fungsi tiroid, CEA, feses lengkap, kultur feses) b. Imaging : USG Abdomen, BNO, Colon in Loop, MSCT Abdomen. c. Kolonoskopi dan biopsi
5	Kriteria Diagnosis	a. Feses cair b. Frekuensi BAB lebih dari 3 kali sehari. c. Berlangsung lebih dari 15 hari
6	Diagnosa Kerja	DIARE KRONIS
7	Diagnosa Banding	a. Inflammatory Bowel disease (IBD) b. Irritable Bowel Syndrome (IBS) c. Kanker Kolorektal d. Malabsorpsi karbohidrat e. Neuropati otonom diabetik f. Obat-obatan g. Alergi makanan h. Hipertiroidisme i. Infeksi : bakteri, virus, amoeba j. Kolitis radiasi k. Kelainan endokrin l. Short Bowel Syndrome



		m. Sindrom maldigesti
8	Terapi	a. Menghentikan/menghilangkan etiologi penyebab diare kronik : makanan, obat-obatan. b. Terapi simptomatik dapat diberikan loperamide
9	Edukasi	Menghentikan makanan atau obat-obatan yang kemungkinan menyebabkan diare kronis.
10	Prognosis	Dubia ad malam
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	a. Penegakan diagnosis: 3 hari b. Lama terapi: 4 hari (kecuali disertai pemberatan komorbid lain)
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	a. Gejala klinis membaik, frekuensi BAB dan bentuk feses normal b. Kriteria laboratorium membaik
14	Kepustakaan	a. Fernandez-Banarez, et al. Chronic Diarrhoea : Definition, classification and diagnosis. Gastroenterol Hepatol. 2016 ; 39 (8) : 535-559 b. Sudoyo A, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. Buku ajar ilmu penyakit dalam. 4th ed. Jakarta; Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2014:1963-1971



PANDUAN PRAKTIK KLINIS DISPEPSIA FUNGSIONAL		
1	Definisi	Terdapatnya satu atau lebih gejala ketidaknyamanan pada sistem gastrointestinal, tanpa adanya kelainan organik yang bisa menjelaskan gejala tersebut.
2	Anamnesis	a. rasa perut penuh sesudah makan (<i>Postprandial Fullness</i>) b. cepat kenyang, c. nyeri dan panas pada epigastrik,
3	Pemeriksaan fisik	a. Thorax: tidak tampak kelainan pada jantung dan paru b. Abdomen: tidak terdapat kelainan pada hepar dan lien c. Tidak terdapat pembesaran kelenjar limfe d. Tidak terdapat massa pada abdomen
4	Pemeriksaan penunjang	a. Uji laboratorium umum: Darah perifer lengkap, ALT, AST, Gamma GT, alkaline fosfatase, bilirubin total, bilirubin direk, ureum, creatinine, fungsi tiroid, amylase, lipase, gula darah b. USG abdomen, c. Barium meal d. Esofagogastroskopi,
5	Kriteria Diagnosis	a. Gejala : rasa perut penuh sesudah makan (<i>Postprandial Fullness</i>), cepat kenyang, nyeri dan panas pada epigastrik b. Endoskopi : tidak tampak adanya kelainan struktural/organic c. Terjadi selama 3 bulan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diagnosis ditegakkan.
6	Diagnosa Kerja	DISPEPSIA FUNGSIONAL
7	Diagnosa Banding	a. Kelainan esofagogastroduodenal : ulus peptic, gastritis, tumor b. Kelainan pancreas : pankreatitis, keganasan c. Hepatobilier : hepatitis, kolesistitis, tumor d. Penyakit Sistemik : DM, Penyakit tiroid, kelainan ginjal, Penyakit Jantung Koroner e. Obat-obatan : NSAID, teofilin, digitalis, antibiotika, dll
8	Terapi	a. Eradikasi <i>Helicobacter Pylori</i> b. Terapi menurunkan keasaman lambung : PPI, H2 RA c. Neuromodulator : amitriptilin d. Prokinetik : domperidon, cisaprid, metoklopramid e. Terapi psikologis
9	Edukasi	Menghindari makanan yang tersebut dibawah : a. Tinggi lemak b. Gandum c. Oligosakarida, disakarida, monosakarida dan pemanis buatan yang difermentasi



		d. Kafein
10	Prognosis	Baik
11	Kompetensi	Level of competence 4A (Sesuai kompetensi dari kolegium)
12	Indikator medis	a. Penegakan diagnosis: 2 hari b. Lama terapi: 3 hari
13	Kriteria pasien pulang rawat inap	Gejala klinis membaik, intake oral baik, tidak ada pemberatan komorbid lain
14	Kepustakaan	a. Harer KN, Hasler WL. Functional Dyspepsia: A Review of the Symptoms, Evaluation, and Treatment Options. Gastroenterology & Hepatology Volume 16, Issue 2 February 2020 b. Mounsey A, et al. Functional Dyspepsia: Evaluation and Management. American Family Physician. January 15, 2020. Volume 101, Number 2 c. Djojoningrat D. Dispepsia Fungsional. In : Sudoyo A, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. 4th ed. Jakarta; Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2014:1963-1971



PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Panduan Praktik Klinis ini diharapkan dapat menjadi Standar Prosedur Operasional bagi dokter spesialis penyakit dalam yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan fasilitas pelayanan kesehatan di RSI Sultan Agung.

Melalui panduan ini diharapkan terselenggara pelayanan medis yang efektif, efisien, bermutu dan merata sesuai sumber daya, fasilitas, pra fasilitas, dana dan prosedur serta metode yang memadai. Semoga bermanfaat.

